HCL HOSPICES CIVILS DE LYON	**Internes de radiothérapie – hors Dr Junior**		
	Fiche de poste	Version n°01 du 24-09-2026	Codification
Emetteur : Service Radiothérapie Oncologie		**Validation :**	
Destinataires : internes, médecins, encadrement paramédical			

SITE : Groupement Hospitalier Lyon Sud
PAM : pôle de Spécialités Médicales
PAVILLON : Marcel Bérard, bâtiment 1F, niveaux -1 à -3
SERVICE : Oncologie Radiothérapie – Curiethérapie
CHEF DE SERVICE : Pr O. CHAPET

Présentation générale du poste

Sous la responsabilité clinique et pédagogique des médecins séniors et du chef de service, l'interne assure la prise en charge clinique, dosimétrique et technique des patients tout au long de leur parcours d'irradiation. Il participe aux consultations initiales, au suivi hebdomadaire sous traitement, à la délinéation anatomique et dosimétrique, à la validation technique au poste de traitement ainsi qu'à la prise en charge des urgences et des questions intercurrentes du service.

Modalités d'organisation, présence et congés

- **Horaires et amplitude**

  - Présence obligatoire d'au moins **un interne dès 8h15** (ouverture et réunion du matin**) jusqu'à la fin des traitements** (fermeture du plateau technique)
  - Présence obligatoire d'au moins **deux internes entre 8h30 et 18h**
  - Au minimum 1 interne présent dans le service en permanence, y compris à midi (relai pour le self)
  - Les 2 lignes téléphoniques doivent être couvertes de 8h15 à la fermeture du service

- **Effectifs et planning**

  - **Effectif minimal requis :** Au minimum 2 internes présents en simultané dans le service, en l'absence de consultation à assurer (consultations Pr Chapet, ou médecins absents). En cas d'effectif exceptionnel réduit à 1 interne, validation préalable impérative par le Dr Lapierre
  - **Gestion des plannings** :
    - Le planning hebdomadaire de **répartition des postes** (interne de technique, interne de surveillance et consultation du chef de service et des médecins absents, absences) est établi 15 jours à l'avance par l'interne référent. Il doit être **noté sur le planning word** du service et transmis aux secrétariats au plus tard le lundi précédent la semaine concernée.
    - Un interne doit être posté sur la **consultation du Pr Chapet du lundi après-midi et du mardi matin**
    - Un interne doit être positionné sur les **consultations en cours de traitement des médecins absents**
    - Un interne doit être positionné sur les consultations d'anciens patients des médecins séniors si indiqué par les secrétaires.

- Le planning prévisionnel des congés et absences doit être renseigné et verrouillé au moins **un mois à l'avance**. Il doit être accessible à tous dans ls\internes
- Les demandes de congés et absences doivent impérativement être saisies sur Chronotime.

- **Organisation en binômes**

  - Fonctionnement en binômes interne-senior tournant tous les 3 mois
  - Présence aux consultations de nouveaux patients et aux visites de surveillance du senior référent
  - Réalisation des contourages du senior référent et partage solidaire des dossiers des seniors dont le binôme interne est absent.
  - Mise en place d'un point d'étape et d'ajustement au terme du premier mois de stage

Activités et missions opérationnelles par poste

- **Poste 1 : Plateau Technique & Scanner (DECT : 36 43 81)**

  - **Réunion du matin (8h15 au scanner)**

  - Préparation des dossiers des patients scannés le jour même
  - Présentation synthétique pour chaque patient : pathologie, indication, vérification formelle de la latéralité (par imagerie ou CRO), projection d'imagerie Easily/PACS si pas d'image clé et traçabilité de la visite « Réunion du matin »
  - Vérification de la créatinine pour les scanners injectés du jour
  - Préparation dans Offline Review de la liste des premières séances de la veille et validation avec le médecin de plateau technique

  - **Supervision du scanner dosimétrique**

  - Vérification des préparations pelvis sur demande des MER
    - Microlax systématique si SBRT prostate
    - Diamètre rectum ant-post <3,5cm pour prostate normo/hypofractionnée
    - Vessie non vide (paroi sup au-dessus de la prostate)
  - Pose des repères radio-opaques (cicatrices, cerclages mammaires, repère vaginal, …) si nécessaire

  - **Intervention aux postes de traitement**

  - Déplacement sur appel des manipulateurs (MER) pour validation des nouveaux départs et recalages complexes
  - Surveillance médicale dédiée (monitoring ECG ou pose d'aimant pour stimulateurs/défibrillateurs).
  - Résolution des difficultés de vacuité rectale ou réplétion vésicale sur appel des MER (avis sondage)
  - En cas de doute : appel du médecin de plateau technique (DECT : 34 35 63)

- **Poste 2 : Surveillance Clinique & Avis Médicaux (DECT : 36 43 82)**

  - **Prise de poste (8h30)**

  - Faire un point avec l'ASD d'accueil au -2 pour voir les consultations à assurer le jour-même, si non indiquées sur le planning hebdomadaire initialement

  - **Surveillance hebdomadaire (en cas de médecin absent)**

  - Voir les patients en consulation
  - Mettre un mot dans la visite « Cs surveillance hebdomadaire » onglet « Journal suivi hebdo »
  - Validation des Offline review du jour
  - Dicter les VFT si nécessaire (voir avec la secrétaire du médecin référent si absence de consigne)

  - **Gestion des urgences**

  - Prise en charge des patients à la demande de l'accueil ou des MER
  - Tracer les visites dans ARIA. **TOUT PATIENT VU DOIT AVOIR UN MOT DANS ARIA**
  - En cas de nécessité de transfert des patients (vers le SAU ou en hospitalisation), penser à demander l'UF du service de destination pour la communiquer à l'ASD d'accueil pour le PTAH

  - **Pose de sonde naso-gastrique**

  - A la demande du médecin sénior
  - Matériel disponible en salle de soin au -2
  - Une fois la SNG en place, faire la demande de radio :
    - Remplir le bon de radiologie
    - Coller les étiquettes du patient (disponibles à la banque d'accueil du -2)
    - Appeler le service de radiologie pour les prévenir et demander l'UF (36 91 00)
    - Prévenir l'ASD d'accueil pour qu'il commande le PTAH
  - Une fois la radio validée, enlever le guide
  - Appeler le prestataire et voir avec les diététiciennes pour mise en place du protocole
  - Prescrire le bilan biologique avant nutrition si non réalisé
  - Noter sur ARIA la longueur de la SNG (graduation au nez)

  - **Soins courants dans le service**

  - Bilan biologique urgent :
    - Remplir le bon de prise de sang (disponible dans les salles de consultation du -2 ou à l'accueil)
    - Mettre une étiquette patient
    - Prévenir les infirmières DECT : 36 21 13
  - Bilan biologique non urgent :
    - Ordonnance pour labo de ville
  - Demande d'ablation de PICC Line :
    - Remplir le bon d'acte (le même que pour les prises de sang)
    - Mettre une étiquette patient

- Prévenir les infirmières DECT : 36 21 13
- Si pas d'urgence : planifier avec les IDE et l'accueil (tracer dans le cahier noir de l'accueil)

➢ Suspicion de PICC Line obstrué :

- A gérer avec l'HDJ onco ou pneumo : DECT 36 38 09

➢ Médicaments :

- Pharmacie disponible au -2 et au -1 avec quelques traitements de premier recours (antiémétiques, antalgiques, anxiolytiques, corticoïdes, …)
- Prévenir les IDE s'il reste peu de médicaments
- Toxiques :
  - Le coffre des toxiques se trouve au -1 en salle de soins.
  - Remplir la feuille rose de traçabilité correspondant au médicament délivré
  - Prévenir les IDE en cas de stock faible, car la dotation du service est limitée

○ **Arrêts de travail**

➢ Les arrêts de travail sont sous clé, à l'accueil du -2 ou au secrétariat au -1.

➢ Bien photocopier la 1e page et le ramener au secrétariat pour intégration dans Easily

○ **Bilans biologiques**

➢ Récupération des bilans 2 fois par jour au niveau -1 (matin et 14h00).

➢ Analyse, et signature

➢ Adaptation thérapeutique si nécessaire : appeler les patients

➢ TRACER DANS ARIA en cas de bilan anormal/modification de traitement

➢ Prévenir le médecin référent en cas d'interruption nécessaire de la chimiothérapie en raison du bilan biologique

○ **Permanence téléphonique**

➢ Réponses aux sollicitations des patients (validation chimiothérapies orales, toxicités retardées) avec

➢ Traçabilité systématique (ARIA si en cours de traitement ou Easily si traitement terminé)

Objectifs pédagogiques et évaluation de stage

- **Compétences générales**

  ➢ Présence quotidienne en staff du matin

  ➢ Présence hebdomadaire au staff du mardi midi

  ➢ Présence aux cours des médecins séniors

  ➢ Participation à un CREX au minimum

  ➢ Présence en RCP

- **Compétences cliniques**

  ➢ Etre en mesure de réaliser une consultation d'annonce de façon autonome

  ➢ Etre en mesure de réaliser des consultations de suivi et de planifier le suivi, avec dictée des VFT

- **Compétences techniques**

  - Contourage des volumes cibles et des OAR
  - Evaluation dosimétrique (avec le médecin sénior)

Numéros téléphone utiles :

Salles de traitement :

- **Novalis (salle 1) : 36.42.97**
- **Halcyon 3 (salle 2) : 36.42.95**
- **Halcyon 2 (salle 3) : 36.42.84**
- **Halcyon 1 (salle 6) : 36.58.89**
- **Scanner (salle 4) : 36.42.82**
- **IRM Linac (hors du service) : 36.57.42**
- **médecin d'astreinte DECT : 34.35.63**
- **manip de dossier (36.10.54)**

Cette fiche de poste est amenée à évoluer selon les nécessités de service.

Auteur : Diamantina CLAMOTE
Approbation : Pr Olivier CHAPET
Contact : Diamantina CLAMOTE, CDS
Date de 1ère version : 04/02/2013